विभिन्न प्रकार की पट्टियों का उपयोग एवं ड्रेसिंग

Bandages and Wound Dressing

ड्रेसिंग और पट्टी की संकल्पना

ड्रेसिंग (**Dressing**) घाव पर या उसके संपर्क में रखी जाने वाली उपयुक्त सामग्री है। यह घाव की सुरक्षा, स्राव सोखने और आवश्यक देखभाल में सहायता करती है। पट्टी (**Bandage**) ड्रेसिंग को स्थिर रखने, घायल भाग को सहारा देने या आवश्यकता के अनुसार दबाव बनाए रखने में उपयोग होती है।

दोनों का अंतर

आधार	ड्रेसिंग	पट्टी
प्रमुख कार्य	घाव की सतह की सुरक्षा और देखभाल	ड्रेसिंग स्थिर रखना तथा सहारा
स्थान	सामान्यतः घाव के संपर्क में	ड्रेसिंग के ऊपर या घायल भाग के आसपास
उदाहरण	कीटाणुरहित गॉज़ और न चिपकने वाला पैड	रोलर, त्रिकोणीय और ट्यूबुलर पट्टी

संयुक्त सामग्री

कुछ तैयार उत्पादों में पैड और उसे स्थिर रखने की व्यवस्था एक साथ होती है। इसलिए किसी उत्पाद का नाम देखने के साथ उसका वास्तविक उपयोग समझना चाहिए।

कौशल की आवश्यकता

बाँधने की विधि का अभ्यास उपयोगी है, लेकिन घाव की गंभीरता और रक्त परिसंचरण की समीक्षा भी जरूरी है। सुंदर दिखने वाली बहुत कसी पट्टी सुरक्षित नहीं होती।

> सही ड्रेसिंग घाव की जरूरत के अनुसार और सही पट्टी सहारे तथा सुरक्षा के अनुसार चुनी जाती है।

ड्रेसिंग और पट्टी के प्रमुख उद्देश्य

Purposes of Dressings and Bandages

उद्देश्य	उपयोग की दिशा
सुरक्षा	बाहरी दूषण और रगड़ से बचाव
स्राव का प्रबंधन	रक्त या अन्य स्राव को उपयुक्त रूप से सोखना
स्थिरता	ड्रेसिंग को सही स्थान पर बनाए रखना
दबाव	आवश्यक स्थिति में रक्तस्राव नियंत्रण में सहायता
सहारा	नरम ऊतक या जोड़ की चोट में आराम
गति कम करना	स्प्लिंट तथा स्लिंग के साथ उपयुक्त सहारा

उद्देश्य के अनुसार चयन

छोटे कट के लिए उपयुक्त पैड और चिपकने वाला प्लास्टर पर्याप्त हो सकता है। जोड़ को सहारा देने के लिए रोलर या सही आकार की ट्यूबुलर पट्टी उपयोगी हो सकती है। गहरी चोट में केवल बाँधना पूरा उपचार नहीं है।

ड्रेसिंग और घाव भरना

घाव को उपयुक्त वातावरण चाहिए। अत्यधिक सूखापन, बहुत अधिक नमी, दूषण तथा लगातार दबाव से परेशानी हो सकती है। देखभाल का निर्णय घाव और व्यक्ति की स्थिति के अनुसार होता है।

प्राथमिक सहायता की सीमा

अनियंत्रित रक्तस्राव, गंभीर जलन, फँसी वस्तु और खुले फ्रैक्चर में तत्काल चिकित्सा आवश्यक है। ड्रेसिंग लगाने के लिए जीवनरक्षक सहायता या परिवहन में देरी न करें।

> हर पट्टी का उद्देश्य दबाव देना नहीं; कई पट्टियाँ केवल ड्रेसिंग या सहारा बनाए रखने के लिए होती हैं।

सामग्री और उपयोगी गुण

Materials and Useful Properties

अच्छी सामग्री की विशेषताएँ

सामग्री साफ, उपयुक्त आकार की, त्वचा के लिए स्वीकार्य और अपने उद्देश्य के अनुरूप हो। घाव के संपर्क वाली सामग्री में गुणवत्ता तथा कीटाणुरहित अवस्था विशेष महत्वपूर्ण है।

सामग्री	प्रमुख गुण और उपयोग
गॉज़ (**Gauze**)	खुले जाल जैसी बुनावट; उपयुक्त पैड और स्राव प्रबंधन
सूती या कैलिको कपड़ा	त्रिकोणीय पट्टी तथा अन्य सहारे
क्रेप (**Crepe**)	लचीलापन; उपयुक्त बंधन और सहारा
इलास्टिक मिश्रित कपड़ा	खिंचाव वाला सहारा; कसावट की सावधानी
न चिपकने वाली परत	घाव की सतह से चिपकाव कम करना
टेप	सही जगह पर पैड या पट्टी का सिरा स्थिर रखना

रूई की सीमा

खुली रूई के रेशे घाव में चिपक सकते हैं। इसे सीधे खुले घाव का सामान्य संपर्क-पैड न बनाएँ। आवश्यकता के अनुसार पैडिंग या अन्य उपयोग पेशेवर योजना में अलग हो सकता है।

उत्पाद की पहचान

कीटाणुरहित पैक, आकार, उपयोग और समाप्ति तिथि देखें। “सफेद कपड़ा” या “नया पैकेट” अपने-आप कीटाणुरहित होने का प्रमाण नहीं है।

> सामग्री की उपयोगिता केवल मोटाई या रंग से नहीं, उद्देश्य, गुणवत्ता और उपयोग की सुरक्षा से तय होती है।

पट्टियों का मुख्य वर्गीकरण

Classification of Bandages

प्रकार	पहचान	प्रमुख उपयोग
रोलर पट्टी (**Roller Bandage**)	लंबी पट्टी रोल में लिपटी	ड्रेसिंग, जोड़ और अंग का सहारा
त्रिकोणीय पट्टी (**Triangular Bandage**)	तीन कोनों वाला कपड़ा	स्लिंग, मोड़कर सहारा और स्थिरता
ट्यूबुलर पट्टी (**Tubular Bandage**)	नली जैसा बुना ढाँचा	ड्रेसिंग स्थिर रखना या उपयुक्त जोड़-सहारा
इलास्टिक पट्टी (**Elastic Bandage**)	खिंचाव वाली सामग्री	निर्धारित सहारा और संपीड़न
चिपकने वाली सामग्री (**Adhesive Tape**)	त्वचा या बाहरी सामग्री पर चिपकना	स्थानीय स्थिरता

वर्गीकरण के अलग आधार

“रोलर” पट्टी के रूप को बताता है और “इलास्टिक” सामग्री के गुण को। इसलिए रोलर पट्टी इलास्टिक भी हो सकती है। दोनों को हमेशा परस्पर अलग वर्ग न समझें।

ट्यूबुलर पट्टी का अंतर

ट्यूबुलर गॉज़ उँगली की ड्रेसिंग स्थिर रख सकता है। इलास्टिक ट्यूबुलर सामग्री जोड़ को सहारा दे सकती है। प्रत्येक ट्यूबुलर पट्टी रक्तस्राव रोकने का दबाव नहीं देती।

अन्य रूप

चार-पूँछ वाली, अनेक-पूँछ वाली और विशेष तैयार पट्टियाँ चयनित चिकित्सकीय उपयोग में मिलती हैं। उनका उपयोग उद्देश्य तथा प्रशिक्षण के अनुसार होता है।

> पट्टी का रूप, सामग्री और बाँधने की तकनीक तीन अलग पहचान हैं।

सफाई, विसंक्रमण और कीटाणुरहित अवस्था

Cleaning, Disinfection and Sterility

आवश्यक अंतर

प्रक्रिया	प्रमुख अर्थ
सफाई (**Cleaning**)	गंदगी और जैविक सामग्री हटाना
विसंक्रमण (**Disinfection**)	वस्तु पर कई रोगकारक सूक्ष्मजीव नष्ट करना; सभी बीजाणु जरूरी नहीं
निर्जीवीकरण (**Sterilization**)	सभी प्रकार के सूक्ष्मजीवी जीवन, बीजाणु सहित, समाप्त करना
एंटीसेप्सिस (**Antisepsis**)	जीवित ऊतक पर उपयुक्त पदार्थ से सूक्ष्मजीव कम करना

ड्रेसिंग में महत्त्व

कीटाणुरहित ड्रेसिंग (**Sterile Dressing**) का पैक सही और बंद हो। घाव से संपर्क करने वाले हिस्से को हाथ या दूषित सतह से छूने पर उसकी सुरक्षित अवस्था प्रभावित हो सकती है।

कपड़ा और पैक

घर में धोया या उबाला कपड़ा उपयोगी साफ सामग्री हो सकता है, लेकिन उसे निश्चित रूप से कीटाणुरहित चिकित्सा-पैक के समान नहीं माना जाता। आपात स्थिति में उपलब्ध साफ, कम रेशे छोड़ने वाला कपड़ा सहायता दे सकता है।

पदार्थ का सही उपयोग

सतह साफ करने वाला कीटाणुनाशक घाव या त्वचा के लिए सुरक्षित हो, यह जरूरी नहीं है। उत्पाद का निर्धारित उपयोग तथा चिकित्सकीय निर्देश देखें।

> साफ, विसंक्रमित और कीटाणुरहित एक ही वैज्ञानिक अवस्था के नाम नहीं हैं।

ड्रेसिंग से पहले तैयारी

Preparation for Dressing

व्यक्ति और स्थान

व्यक्ति को प्रक्रिया समझाएँ और आरामदायक स्थिति दें। पर्याप्त प्रकाश, साफ कार्यस्थल और सामग्री की उपलब्धता रखें। गंभीर रक्तस्राव में तैयारी के कारण दबाव देने में देरी न करें।

आवश्यक सामग्री

- उपयुक्त कीटाणुरहित पैड, गॉज़ और न चिपकने वाली ड्रेसिंग।
- सुरक्षित टेप या सही आकार की पट्टी।
- हाथ की सफाई तथा उपलब्ध गैर-लेटेक्स दस्ताने।
- छोटे सामान्य घाव के लिए साफ पानी या निर्धारित सलाइन।
- उपयोग की गई सामग्री के लिए अलग अपशिष्ट थैली।

हाथ और संपर्क

हाथ साफ करें। दस्ताने हाथ की सफाई का विकल्प नहीं हैं। पुरानी दूषित ड्रेसिंग हटाने के बाद हाथ की सफाई तथा नए चरण के लिए आवश्यक दस्ताने की व्यवस्था करें।

पहचान और एलर्जी

चिपकने वाली सामग्री, लेटेक्स या अन्य ज्ञात एलर्जी पूछें। बच्चे, वृद्ध और संवेदनशील त्वचा में सामग्री तथा टेप का चयन सावधानी से करें।

सामग्री खोलना

पैक का किनारा खोलें और घाव-संपर्क भाग को छुए बिना संभालें। साफ और दूषित सामग्री के रास्ते अलग रखें।

> व्यवस्थित तैयारी ड्रेसिंग के दौरान अनावश्यक स्पर्श, देरी और दूषण कम करती है।

घाव का प्रारंभिक आकलन

Initial Wound Assessment

क्या देखना चाहिए?

घाव कैसे और कब हुआ, उसकी जगह, रक्तस्राव, गहराई, दूषण और व्यक्ति की स्थिति समझें। केवल घाव की लंबाई उसके खतरे का पूरा संकेत नहीं है।

संकेत	आवश्यक कार्रवाई
भारी या लगातार रक्तस्राव	तुरंत दबाव और आपात सहायता
फँसी वस्तु या बाहर निकली हड्डी	न निकालें या न धकेलें; चिकित्सा
सुन्नपन या गति कम होना	तंत्रिका या अन्य चोट की समीक्षा
काटने या गहरे छेद का घाव	संक्रमण और संबंधित सुरक्षा का आकलन
बढ़ता दर्द, पस या बुखार	संक्रमण की संभावना पर चिकित्सा

विशेष स्थान

आँख, चेहरा, हाथ, जोड़ तथा बड़ी छाती-पेट की चोट में अलग व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे घाव को सामान्य छोटे कट की प्रक्रिया से न संभालें।

व्यक्ति का जोखिम

मधुमेह, कम रक्त परिसंचरण, प्रतिरक्षा की समस्या और रक्त पतला करने वाली दवा की जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है।

सहायता की सीमा

गहरे घाव की टोह लेना, ऊतक काटना और खुद टाँका लगाना प्राथमिक घरेलू सहायता का भाग नहीं है।

> घाव देखकर पहले यह तय करें कि सामान्य ड्रेसिंग पर्याप्त है या तत्काल विशेषज्ञ सहायता चाहिए।

छोटे सामान्य घाव की ड्रेसिंग

Dressing a Minor Wound

प्रक्रिया का क्रम

1	तैयारी	हाथ की सफाई, सामग्री और आरामदायक स्थिति।
2	आकलन और सफाई	रक्तस्राव तथा गंभीरता; छोटे सामान्य घाव की उचित सफाई।
3	पैड रखना	घाव-संपर्क भाग को छुए बिना पर्याप्त आवरण।
4	स्थिरता और समीक्षा	उपयुक्त पट्टी, आराम और परिसंचरण की जाँच।

सफाई की दिशा

रक्तस्राव नियंत्रित होने के बाद छोटे सामान्य घाव को साफ बहते पानी से धीरे धो सकते हैं। आसपास की त्वचा साफ करें और गंदगी घाव के भीतर न ले जाएँ। घाव को जोर से रगड़ना उचित नहीं है।

संपर्क-पैड

पैड घाव के किनारों से आगे तक पर्याप्त क्षेत्र ढके। किनारों से पकड़कर रखें; घाव से लगने वाला भाग न छुएँ।

स्थिर करना

टेप या उपयुक्त रोलर पट्टी उपयोग करें। टेप को अंग के पूरे घेरे में कसकर न लपेटें। स्थिरता के बाद आराम और दूर के भाग का रक्त परिसंचरण देखें।

प्रक्रिया की सीमा

यह छोटे सामान्य घाव की दिशा है। गंभीर रक्तस्राव, गहरे छेद, फँसी वस्तु, शल्य घाव और अन्य विशेष चोट में संबंधित चिकित्सा योजना आवश्यक है।

> घाव-संपर्क भाग को छुए बिना ड्रेसिंग लगाना और अनावश्यक कसावट से बचना मुख्य आधार हैं।

सामान्य ड्रेसिंग के प्रकार

Common Types of Dressings

प्रकार	प्रमुख उपयोग	ध्यान देने योग्य बात
साधारण गॉज़ पैड	सुरक्षा और उपयुक्त स्राव सोखना	घाव में चिपकाव की संभावना देखें
न चिपकने वाला पैड (**Non-Adherent Pad**)	संपर्क-सतह से चिपकाव कम करना	बाहरी स्थिरता की जरूरत हो सकती है
चिपकने वाला प्लास्टर (**Adhesive Plaster**)	छोटे कट और खरोंच	पैड घाव पर, चिपकने वाला भाग आसपास की त्वचा पर
तैयार घाव ड्रेसिंग	पैड तथा बंधन की संयुक्त व्यवस्था	आकार, पैक और निर्देश देखें
पारदर्शी फिल्म (**Film Dressing**)	चयनित सतही घाव या सुरक्षा	अधिक स्राव वाले हर घाव के लिए नहीं

प्राथमिक और द्वितीयक ड्रेसिंग

प्राथमिक ड्रेसिंग (**Primary Dressing**) घाव के संपर्क में रहती है। द्वितीयक ड्रेसिंग (**Secondary Dressing**) उसके ऊपर सुरक्षा, अवशोषण या स्थिरता में सहायता कर सकती है। हर उत्पाद में दोनों अलग परतों के रूप में जरूरी नहीं हैं।

चयन का आधार

घाव का स्थान, स्राव, त्वचा, दर्द और आगे की देखभाल की योजना देखें। केवल मोटा पैड लगाना हर जरूरत का समाधान नहीं है।

> उपयुक्त ड्रेसिंग का चयन घाव की प्रकृति के अनुसार होता है।

विशेष घाव देखभाल की ड्रेसिंग

Specialist Wound Dressings

सामग्री के कार्य का परिचय

विशेष ड्रेसिंग का चयन घाव के पेशेवर आकलन के बाद किया जाता है। नीचे उनके सामान्य कार्य बताए गए हैं; यह स्वयं उपचार तय करने की सूची नहीं है।

प्रकार	सामान्य कार्य की दिशा
फोम (**Foam**)	उपयुक्त मात्रा के स्राव का अवशोषण और सुरक्षा
एल्जिनेट (**Alginate**)	अधिक स्राव वाले चयनित घाव में द्रव सोखना और जेल बनना
हाइड्रोजेल (**Hydrogel**)	चयनित सूखे घाव को नमी देना
हाइड्रोकोलॉइड (**Hydrocolloid**)	चयनित घाव में नमी तथा जेल बनाने वाला वातावरण
प्रतिजीवाणु ड्रेसिंग (**Antimicrobial Dressing**)	जरूरत के अनुसार सूक्ष्मजीव नियंत्रण का अतिरिक्त साधन

नमी का संतुलन

उपयुक्त नम वातावरण उपयोगी हो सकता है, लेकिन आसपास की त्वचा लगातार भीगने से गल सकती है। अत्यधिक नमी से त्वचा का नरम और क्षतिग्रस्त होना **Maceration** कहलाता है।

चिकित्सा के साथ संबंध

संक्रमण, रक्त परिसंचरण और दबाव के कारण का उपचार जरूरी हो सकता है। प्रतिजीवाणु ड्रेसिंग उस पूरी जरूरत या आवश्यक एंटीबायोटिक का स्वतः विकल्प नहीं है।

घरेलू पदार्थ से अंतर

विशेष चिकित्सा उत्पाद और घर की सामान्य वस्तु एक जैसे नहीं हैं।

> विशेष ड्रेसिंग का कार्य समझें, लेकिन उसका चयन घाव-विशेष योजना के अनुसार करें।

ड्रेसिंग बदलना और बाद की देखभाल

Changing Dressings and Aftercare

कब बदलना चाहिए?

बदलने का समय घाव, सामग्री और देखभाल योजना पर निर्भर है। साधारण ड्रेसिंग भीग, गंदी, ढीली या स्राव से भर जाए तो समीक्षा और आवश्यक बदलाव चाहिए। हर प्रकार को दिन में एक ही बार बदलने का नियम नहीं है।

हटाने की सावधानी

टेप धीरे हटाएँ तथा नाजुक त्वचा को सहारा दें। छोटे सामान्य घाव की ड्रेसिंग चिपक गई हो तो उपयुक्त पानी या सलाइन से नरम करके धीरे हटाना उपयोगी हो सकता है। जोर से खींचकर नई चोट न दें।

साफ और दूषित चरण

पुरानी ड्रेसिंग अलग थैली में रखें, हाथ साफ करें और नई ड्रेसिंग की सुरक्षित प्रक्रिया अपनाएँ। पुराना पैड पलटकर दोबारा घाव पर न रखें।

निगरानी

बदलाव	कार्रवाई
बढ़ता दर्द या सूजन	घाव और पट्टी की समीक्षा
पस, बदबू या फैलती लालिमा	चिकित्सा सलाह
बुखार या तेजी से बिगड़ना	शीघ्र चिकित्सा
रक्तस्राव फिर अधिक होना	तत्काल दबाव और उचित सहायता

> ड्रेसिंग बदलने का उद्देश्य घाव को बार-बार परेशान करना नहीं, उपयुक्त देखभाल और निगरानी बनाए रखना है।

पट्टी बाँधने के सामान्य सिद्धांत

General Principles of Bandaging

रोलर पट्टी के भाग

रोल वाले भाग को **Head** और खुले मुक्त छोर को **Tail** कहा जाता है। एक छोर से लिपटी पट्टी **Single-Headed Roller** तथा दोनों छोरों से बीच की ओर लिपटी पट्टी **Double-Headed Roller** कहलाती है।

व्यक्ति और अंग की तैयारी

व्यक्ति को आरामदायक स्थिति दें और घायल भाग को सहारा रखें। गंभीर चोट या जोड़ खिसकने के संदेह में उसे जोर देकर नई स्थिति में न लाएँ।

रोलर पट्टी के आधार

- उपयुक्त चौड़ाई और सामग्री चुनें।
- रोल को पास रखकर धीरे खोलें; लंबी ढीली पट्टी हवा में न लटकाएँ।
- चक्कर समान, सपाट और बिना सिलवट हों।
- जहाँ उपयुक्त हो, संकरे हिस्से से ऊपर की ओर बढ़ें।
- सिरा सुरक्षित रखें; गाँठ या कठोर फास्टनर घाव पर न आए।

ओवरलैप और कसावट

ओवरलैप (**Overlap**) में नया चक्कर पिछले चक्कर का कुछ भाग ढकता है। सामान्य रोलर विधियों में लगभग दो-तिहाई ओवरलैप प्रचलित है; विशेष उत्पाद के निर्देश अलग हो सकते हैं।

पट्टी इतनी दृढ़ हो कि सहारा रहे, लेकिन दर्द, सुन्नपन या रक्त परिसंचरण की बाधा न हो। इलास्टिक सामग्री को अधिक खींचना दबाव बढ़ा सकता है।

बाद की जाँच

संभव हो तो उँगलियों या पैर की उँगलियों के सिरे खुले रखें। बाँधने से पहले और बाद में उनकी स्थिति देखें।

> विधि का अच्छा आकार तभी उपयोगी है जब पट्टी आरामदायक और परिसंचरण के लिए सुरक्षित हो।

रक्त परिसंचरण, संवेदना और गति की जाँच

Circulation, Sensation and Movement

पट्टी के आगे का भाग

घायल स्थान से दूर उँगलियों में रंग, गर्माहट, संवेदना और संभव सुरक्षित गति देखें। बढ़ती सूजन तथा दर्द को भी ध्यान में रखें।

केशिका पुनर्भरण

नाखून या उपयुक्त त्वचा को लगभग 5 सेकंड हल्का दबाकर छोड़ें। सामान्यतः लगभग 2 सेकंड में रंग लौटना चाहिए। देर से लौटना चिंताजनक हो सकता है, लेकिन ठंड और अन्य परिस्थितियाँ भी परिणाम प्रभावित करती हैं।

संकेत	सावधानी
सुन्नपन या झनझनाहट	कसावट या चोट की समस्या देखें
ठंडी, पीली या नीली उँगली	परिसंचरण की तत्काल समीक्षा
बहुत दर्द या बढ़ती सूजन	पट्टी और चोट की जाँच
रंग देर से लौटना	सामान्य सहारे की पट्टी ढीली करके पुनः आकलन

नियमित समीक्षा

प्राथमिक सहायता में बाँधने के तुरंत बाद और लगभग हर 10 मिनट दोबारा देखना उपयोगी है। बदलाव पहले हो तो तुरंत जाँचें।

महत्वपूर्ण अपवाद

जीवनघाती रक्तस्राव के लिए लगाया टूर्निकेट सामान्य सहारा-पट्टी नहीं है; उसे स्वयं ढीला न करें। गंभीर चोट या समस्या बनी रहे तो तत्काल चिकित्सा चाहिए।

> नाखून की जाँच अकेला प्रमाण नहीं; रंग, ताप, संवेदना, दर्द और पूरी स्थिति साथ देखें।

रोलर पट्टी की प्रमुख विधियाँ

Major Roller Bandaging Methods

विधि	चक्करों का ढाँचा	सामान्य उपयोग
वृत्ताकार (**Circular**)	उसी स्तर पर गोल चक्कर	शुरुआत या अंत स्थिर करना
सर्पिल (**Spiral**)	हर चक्कर थोड़ा ऊपर	लगभग समान मोटाई का अंग
उलटी सर्पिल (**Spiral Reverse**)	बढ़ते चक्कर में पट्टी पलटना	शंकु जैसी मोटाई बदलने वाला भाग
आठाकार (**Figure-of-Eight**)	दो क्षेत्रों के बीच तिरछे क्रॉस	जोड़ और हाथ-पैर का सहारा
स्पाइका (**Spica**)	क्रमिक आठाकार और प्रगतिशील ढकाव	अंगूठा, कंधा या कूल्हे के चयनित क्षेत्र
आवर्ती (**Recurrent**)	सिरे के ऊपर आगे-पीछे चक्कर	उँगली, सिर या अंग के गोल सिरे का ढकाव

सामग्री और तकनीक

गैर-लचीली सामग्री से आकार के अनुसार चक्कर बदलना पड़ सकता है। लचीली और आकार में ढलने वाली आधुनिक सामग्री कुछ स्थितियों में साधारण सर्पिल से भी ठीक बैठ सकती है।

चयन का अभ्यास

कलाई, जोड़ और गोल सिरे की बनावट अलग होती है। एक ही तकनीक हर क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त नहीं होती।

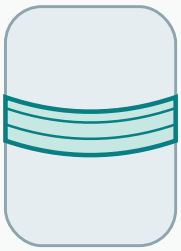
> **Circular**, **Spiral** और **Figure-of-Eight** बाँधने के तरीके हैं; रोलर पट्टी उनका सामान्य साधन हो सकती है।

वृत्ताकार पट्टी

Circular Bandaging

पहचान

वृत्ताकार विधि (**Circular Bandaging**) में चक्कर लगभग उसी स्तर पर आते हैं। अगले चक्कर का अधिक भाग पिछले चक्कर को ढकता है।



उसी स्तर पर चक्कर

आरंभ या अंत स्थिर करना।

तकनीक का सरल ढाँचा

सामान्य उपयोग

किसी अन्य रोलर विधि की शुरुआत में पट्टी का सिरा स्थिर करना तथा अंत में सुरक्षित बंधन देना इसके सामान्य उपयोग हैं। छोटे क्षेत्र की ड्रेसिंग को स्थिर करने में भी इसका उपयोग हो सकता है।

अभ्यास की दिशा

अंग को सहारा दें। मुक्त छोर को उपयुक्त स्थान पर रखें और लगभग दो चक्कर देकर स्थिर करें। फिर जरूरत के अनुसार अगली तकनीक या सुरक्षित फास्टनिंग करें।

सावधानी

एक ही जगह बहुत चक्कर दबाव की मोटी पट्टी बना सकते हैं। गाँठ, टेप या सिलवट से स्थानीय दबाव बढ़ सकता है। रक्त परिसंचरण देखें।

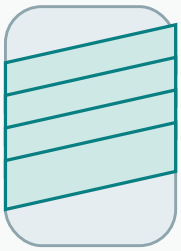
> वृत्ताकार चक्कर लंबा क्षेत्र ढकने के बजाय उसी स्तर पर पकड़ और स्थिरता देते हैं।

सर्पिल पट्टी

Spiral Bandaging

पहचान

सर्पिल विधि (**Spiral Bandaging**) में पट्टी अंग के चारों ओर घूमते हुए धीरे-धीरे ऊपर बढ़ती है। हर चक्कर पिछले का कुछ भाग ढकता है।



ऊपर बढ़ते चक्कर

अगला चक्कर पिछले का भाग ढकता है।

तकनीक का सरल ढाँचा

उपयोग का आधार

लगभग बेलनाकार या समान मोटाई वाले क्षेत्र पर यह सरल ढाँचा है। आकार में ढलने वाली सामग्री से बदलती मोटाई वाले क्षेत्र पर भी उपयुक्त उपयोग संभव हो सकता है।

प्रक्रिया की दिशा

शुरुआत स्थिर करें। पट्टी को समान तनाव से ऊपर ले जाएँ और सामान्य रूप से लगभग दो-तिहाई ओवरलैप रखें। ड्रेसिंग ढक जाने पर सिरा सुरक्षित करें तथा परिसंचरण जाँचें।

गलतियों से बचाव

ओवरलैप कम हो तो बीच में खाली जगह और ढीलापन आ सकता है। बहुत अधिक चक्कर तथा अधिक खिंचाव से दबाव बढ़ सकता है।

चित्र का अर्थ

आरेख चक्कर का बढ़ता ढाँचा दिखाता है। वास्तविक पट्टी की चौड़ाई और चक्करों की संख्या क्षेत्र तथा सामग्री के अनुसार चुनी जाती है।

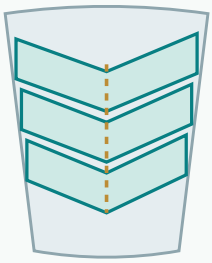
> सर्पिल में चक्कर आगे बढ़ते हैं; वृत्ताकार में अधिकांश चक्कर उसी स्तर पर रहते हैं।

उलटी सर्पिल पट्टी

Spiral Reverse Bandaging

पहचान

उलटी सर्पिल (**Spiral Reverse**) में सर्पिल चक्कर के दौरान पट्टी को स्वयं पर पलटकर मोड़ बनाया जाता है। इससे गैर-लचीली सामग्री बदलती मोटाई पर बेहतर बैठ सकती है।



क्रमिक पलटा हुआ मोड़

बदलती मोटाई पर पट्टी बैठाना।

तकनीक का सरल ढाँचा

उपयोग

अग्रबाहु या पिंडली जैसे शंकु के समान आकार वाले क्षेत्र में इस विधि का परंपरागत उपयोग होता है। आकार में ढलने वाली इलास्टिक सामग्री के कारण कई स्थितियों में साधारण सर्पिल भी पर्याप्त हो सकती है।

तकनीक के मुख्य बिंदु

शुरुआत स्थिर करने के बाद चक्कर आगे बढ़ाएँ। आवश्यक स्थान पर पट्टी पलटें और अगला भाग सपाट रखें। मोड़ क्रमबद्ध हों तथा घाव या हड्डी के उभरे स्थान पर मोटा दबाव न बनाएँ।

विशेष सावधानी

मोड़ बनाते समय अधिक खींचना, गुच्छा बनना और असमान कसावट सुरक्षित सहारा कम करते हैं। इस कौशल का अभ्यास प्रशिक्षक की निगरानी में करें।

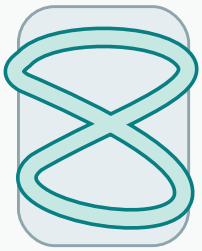
> उलटी सर्पिल का उद्देश्य आकार के अनुसार पट्टी बैठाना है, दबाव को अधिकतम करना नहीं।

आठाकार पट्टी

Figure-of-Eight Bandaging

पहचान

आठाकार विधि (**Figure-of-Eight Bandaging**) में पट्टी दो क्षेत्रों के चारों ओर घूमती है और बीच में तिरछे भाग एक-दूसरे को काटते हैं। इसका ढाँचा अंग्रेज़ी अंक 8 से मिलता है।



दो क्षेत्रों के बीच क्रॉस

जोड़ के आसपास आठाकार ढाँचा।

तकनीक का सरल ढाँचा

सामान्य उपयोग

कलाई, टखना, कोहनी और घुटने जैसे क्षेत्रों में सहारा या ड्रेसिंग स्थिर रखने के लिए उपयोग होता है। क्षेत्र के अनुसार क्रॉस और चक्करों की दिशा बदल सकती है।

प्रक्रिया की दिशा

आरंभिक पकड़ बनाएँ। जोड़ के ऊपर और नीचे चक्कर ले जाकर तिरछा क्रॉस बनाएँ। आवश्यक क्षेत्र क्रमशः ढकें और अंत सुरक्षित करें।

जोड़ की स्थिति

साधारण नरम ऊतक की चोट में आरामदायक हल्का मोड़ उपयोगी हो सकता है। संदिग्ध फ्रैक्चर या जोड़ खिसकने में नई स्थिति बनाने के लिए जबरदस्ती न मोड़ें।

सावधानी

जोड़ के अंदरूनी मोड़ में पट्टी की भीड़ या अधिक तनाव से दर्द और दबाव बढ़ सकता है। समान सहारा और परिसंचरण की जाँच आवश्यक हैं।

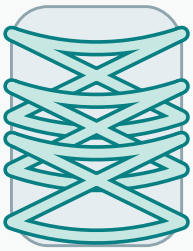
> आठाकार में क्रॉसिंग मुख्य पहचान है; सुरक्षित उपयोग के लिए अंग की स्थिति और कसावट भी महत्वपूर्ण हैं।

स्पाइका पट्टी

Spica Bandaging

पहचान

स्पाइका (**Spica Bandaging**) आठाकार विधि का क्रमिक रूप है। चक्कर आगे बढ़ते हुए संबंधित क्षेत्र ढकते हैं और तिरछे भाग बालीनुमा ढाँचा बनाते हैं।



आगे बढ़ते आठाकार चक्कर

क्रमिक ढकाव और बालीनुमा क्रॉस।

तकनीक का सरल ढाँचा

सामान्य क्षेत्र

अंगूठे, कंधे और कूल्हे जैसे क्षेत्रों में चयनित स्पाइका विधियाँ पढ़ाई जाती हैं। इनका पूरा रास्ता क्षेत्र के अनुसार अलग होता है।

आठाकार से संबंध

आठाकार और स्पाइका पूरी तरह असंबंधित तकनीक नहीं हैं। स्पाइका में क्रमिक बढ़ते क्रॉस और बड़े या विशिष्ट क्षेत्र का ढकाव पहचान का आधार है।

अंगूठे का उदाहरण

कलाई पर आरंभिक स्थिरता बनाकर अंगूठे और कलाई के बीच क्रमिक तिरछे चक्कर लिए जाते हैं। अंगूठे का सिरा, आराम और रक्त परिसंचरण देखा जाता है।

चिकित्सकीय स्पाइका कास्ट से अंतर

मुलायम कपड़े की स्पाइका पट्टी और प्लास्टर का स्पाइका कास्ट एक ही सामग्री या एक ही स्तर की प्रक्रिया नहीं हैं। कास्ट और जटिल बंधन पेशेवर कार्य हैं।

> स्पाइका का रूप आठाकार से जुड़ा है; उसका चयन अंग और उद्देश्य के अनुसार होता है।

आवर्ती और कैपेलीन पट्टी

Recurrent and Capeline Bandages

आवर्ती विधि

आवर्ती पट्टी (**Recurrent Bandaging**) में पट्टी गोल या बंद सिरे के ऊपर एक ओर से दूसरी ओर जाती है और लौटती है। ये आगे-पीछे चक्कर सिरा ढकते हैं; वृत्ताकार चक्कर उन्हें स्थिर कर सकते हैं।



सिरे के ऊपर लौटते चक्कर

आगे-पीछे ढकाव और आधार पर स्थिरता।

तकनीक का सरल ढाँचा

सामान्य उपयोग

उँगली के सिरे, सिर की खोपड़ी का बाहरी क्षेत्र और चयनित अंग-सिरे की ड्रेसिंग में यह ढाँचा उपयोग होता है। शल्यक्रिया के बाद अंग-सिरे का संपीड़न अलग चिकित्सकीय योजना है।

कैपेलीन का परिचय

कैपेलीन (**Capeline Bandage**) सिर के बालों वाले क्षेत्र को ढकने की परंपरागत पट्टी है। इसमें दो-सिरों वाली रोलर (**Double-Headed Roller**) या विशेष रोलर व्यवस्था तथा आवर्ती चक्कर का उपयोग सिखाया जा सकता है।

सावधानी

संदिग्ध खोपड़ी फ्रैक्चर या गहरी वस्तु पर दबाव न दें। सिर की चोट में व्यक्ति की चेतना और साँस की समीक्षा ड्रेसिंग के आकार से अधिक महत्वपूर्ण है।

भिन्नता

आवर्ती चक्कर सिरे के ऊपर आगे-पीछे चलते हैं; सर्पिल चक्कर अंग के चारों ओर आगे बढ़ते हैं।

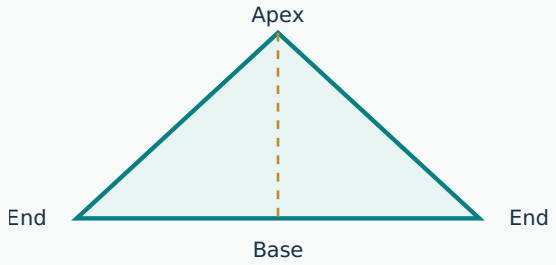
> सिर का ढकाव और गंभीर सिर की चोट का उपचार अलग कार्य हैं।

त्रिकोणीय पट्टी के भाग और मोड़

Triangular Bandage: Parts and Folds

प्रमुख भाग

त्रिकोणीय पट्टी के लंबे किनारे को आधार (**Base**), उसके सामने के कोने को शीर्ष (**Apex**) और आधार के दोनों कोनों को छोर (**Ends**) कहा जाता है।



शीर्ष आधार के सामने होता है; लंबे किनारे के दोनों कोने छोर हैं।

उपयोग के रूप

रूप	पहचान	उपयोग की दिशा
खुली पट्टी (**Open Triangle**)	पूरा त्रिभुज खुला	स्लिंग या बड़े क्षेत्र का उपयुक्त ढकाव
चौड़ी मोड़ी पट्टी (**Broad Fold**)	शीर्ष को आधार की ओर मोड़कर चौड़ी पट्टी	सहारा और चयनित स्थिरता
संकरी मोड़ी पट्टी (**Narrow Fold**)	चौड़ी पट्टी को फिर मोड़कर संकरा रूप	चयनित बाँधने की आवश्यकता

आकार

पट्टी व्यक्ति और उपयोग के अनुरूप पर्याप्त बड़ी हो। केवल एक निश्चित आकार को हर आयु और हर उद्देश्य के लिए अनिवार्य न मानें।

ड्रेसिंग से संबंध

साफ त्रिकोणीय कपड़ा सहारा देने में उपयोगी है, लेकिन वह कीटाणुरहित घाव-संपर्क पैड के समान नहीं है। खुले घाव पर आवश्यक ड्रेसिंग का ध्यान रखें।

> त्रिकोणीय पट्टी एक ही कपड़े से कई रूप देती है; रूप का चयन उद्देश्य के अनुसार करें।

गाँठ, फास्टनिंग और सुरक्षित स्थिरता

Knots and Safe Fastening

रीफ गाँठ

त्रिकोणीय पट्टी में रीफ गाँठ (**Reef Knot**) सपाट बंधन देने के लिए उपयोग होती है। क्रम है: दायाँ छोर बाएँ के ऊपर और नीचे; फिर बायाँ छोर दाएँ के ऊपर और नीचे।

गाँठ का स्थान

गाँठ घाव, हड्डी के उभरे भाग या गर्दन के पीछे दबाव देने वाली जगह पर न आए। स्लिंग में उसे उपयुक्त कंधे के पास तथा आवश्यक नरम सहारे के साथ रखा जाता है।

गलत गाँठ से अंतर

दोनों आधे बंधन एक ही दिशा में बना देने से ग्रैनी गाँठ (**Granny Knot**) बन सकती है। वह अलग ढाँचा है और उपयुक्त सपाट रीफ गाँठ का पर्याय नहीं है।

अन्य तरीके

साधन	सावधानी
टेप	त्वचा की एलर्जी और पूरे अंग को कसने से बचाव
सुरक्षा पिन	बंद हो; नुकीला भाग त्वचा की ओर न आए
सिरा अंदर रखना	स्थिर रहे लेकिन गुच्छा या दबाव न बने

गाँठ और कसावट

गाँठ का सही रूप अधिक कसावट को सुरक्षित नहीं बनाता। पूरी पट्टी, त्वचा और परिसंचरण की समीक्षा आवश्यक है।

> गाँठ का कार्य बंधन स्थिर रखना है; उसे घायल भाग पर दबाव-बिंदु न बनने दें।

सामान्य आर्म स्लिंग

The Arm Sling

उद्देश्य

आर्म स्लिंग (**Arm Sling**) अग्रबाहु, कलाई या ऊपर की बाँह की चयनित चोट में सहारा देती है। हाथ को आरामदायक क्षैतिज या थोड़ा उठा स्थान मिल सकता है।

लगाने की प्रक्रिया

1	**सहारा**	व्यक्ति की बाँह को आरामदायक स्थिति में सहारा दें।
2	**कपड़ा रखना**	अग्रबाहु के नीचे त्रिकोण; शीर्ष कोहनी के पास।
3	**छोर मिलाना**	निचला छोर ऊपर लाकर दोनों छोर कंधे के पास मिलाएँ।
4	**सुरक्षित बाँधना**	रीफ गाँठ, कोहनी का सहारा और उँगलियों की जाँच।

पूर्ण सहारा

स्लिंग अग्रबाहु को कोहनी से छोटी उँगली के आधार तक सहारा दे। उँगलियों के सिरे दिखें। कोहनी के पास कपड़ा सुरक्षित रखें, लेकिन गाँठ या पिन त्वचा पर न चुभे।

व्यक्ति की स्थिति

यदि बाँह को मोड़ने या सामान्य स्लिंग की स्थिति में लाने से बहुत दर्द हो तो जोर न दें। संदिग्ध फ्रैक्चर या कंधा खिसकने में घायल स्थिति को सहारा तथा चिकित्सा प्राथमिकता है।

निगरानी

उँगलियों का रंग, ताप और संवेदना देखें। लगभग हर 10 मिनट या परेशानी होने पर तुरंत समीक्षा करें। गर्दन पर अत्यधिक खिंचाव न हो।

> स्लिंग चोट को सहारा देती है; हड्डी या जोड़ को स्वयं ठीक स्थिति में नहीं बैठाती।

ऊँची स्लिंग और अन्य सहारे

Elevation Sling and Other Supports

एलिवेशन स्लिंग

एलिवेशन स्लिंग (**Elevation Sling**) में अग्रबाहु और हाथ सामान्य आर्म स्लिंग से अधिक ऊँचे रखे जाते हैं। चयनित हाथ या अग्रबाहु की चोट में सूजन तथा असुविधा कम करने में सहयोग मिल सकता है।

प्रक्रिया की दिशा

आरामदायक हो तो व्यक्ति घायल हाथ को छाती के पार रखते हुए उँगलियाँ दूसरे कंधे की ओर रखता है। त्रिकोणीय कपड़ा हाथ और अग्रबाहु को सहारा देता है तथा सिरों को उपयुक्त कंधे के पास रीफ गाँठ से स्थिर किया जाता है। कोहनी के पास कपड़ा सुरक्षित रखें।

दोनों स्लिंग में अंतर

आधार	आर्म स्लिंग	एलिवेशन स्लिंग
हाथ की स्थिति	लगभग क्षैतिज या हल्की ऊँचाई	अधिक ऊँचा सहारा
प्रमुख उपयोग	बाँह-अग्रबाहु का सामान्य सहारा	चयनित हाथ-अग्रबाहु में उठी स्थिति
समीक्षा	आराम और परिसंचरण	आराम और परिसंचरण

अन्य सहारे

कॉलर और कफ (**Collar and Cuff**) या तैयार स्लिंग विशेष निर्देश से उपयोग होते हैं। हर चोट में एक ही रूप नहीं चुना जाता।

> दर्द बढ़े या गंभीर चोट का संदेह हो तो हाथ को जबरदस्ती ऊँचा न करें।

हाथ, उँगली और ट्यूबुलर ड्रेसिंग

Hand, Finger and Tubular Bandages

हाथ पर रोलर पट्टी

पहले आवश्यक पैड रखें। कलाई पर सिरा स्थिर करके पट्टी हाथ के पीछे से तिरछी ले जाएँ और हाथ-कलाई के बीच आठाकार चक्कर बनाएँ। उँगलियों के सिरे खुले रखें और अंत सुरक्षित करें।

उँगली पर सहारा

छोटी ड्रेसिंग को सही आकार की हल्की पट्टी या ट्यूबुलर गॉज़ से स्थिर किया जा सकता है। बहुत संकरी या बहुत खिंची सामग्री स्थानीय दबाव बढ़ा सकती है।

ट्यूबुलर सामग्री का चयन

प्रकार	उपयोग
ट्यूबुलर गॉज़	उँगली की ड्रेसिंग स्थिर रखना; आवश्यक एप्लिकेटर
इलास्टिक ट्यूबुलर पट्टी	निर्धारित सहारा; सही आकार और परत
तैयार उँगली ड्रेसिंग	उत्पाद के अनुसार संपर्क-पैड और आवरण

सुरक्षित उपयोग

एप्लिकेटर (**Applicator**) को जबरदस्ती न चढ़ाएँ। पट्टी के किनारे को मोड़कर कसी अंगूठी न बनाएँ। अंगूठी या आभूषण सूजन से पहले सुरक्षित हटाना उपयोगी हो सकता है।

निगरानी

दर्द, रंग, ठंडापन और सुन्नपन देखें। फँसी वस्तु, टेढ़ी उँगली या संवेदना कम होने पर चिकित्सा लें।

> उँगली की छोटी चोट में भी अधिक कसावट रक्त परिसंचरण बाधित कर सकती है।

कोहनी और घुटने की पट्टी

Elbow and Knee Bandaging

जोड़ पर सहारा

साधारण नरम ऊतक की चोट में कोहनी या घुटने को आरामदायक हल्का मोड़ देकर सहारा दिया जा सकता है। फ्रैक्चर या जोड़ खिसकने का संदेह हो तो नई स्थिति बनाने के लिए जोर न दें।

आठाकार प्रक्रिया

- ड्रेसिंग या पैडिंग की आवश्यक व्यवस्था रखें।
- आरंभिक चक्कर से पट्टी और सिरा स्थिर करें।
- जोड़ के ऊपर और नीचे क्रमशः तिरछे चक्कर लें।
- क्षेत्र को समान सहारा देते हुए जरूरत के अनुसार ढकें।
- अंत सुरक्षित करें तथा दूर की उँगलियों का परिसंचरण देखें।

अंदरूनी मोड़

पट्टी को जोड़ के अंदर भीड़ के रूप में जमा न होने दें। सिलवट, मोटी गाँठ या अधिक तनाव से दर्द तथा दबाव बढ़ सकता है।

सहायता का उद्देश्य

सहारा से आराम मिल सकता है, लेकिन बहुत दर्द, भार न रख पाना, टेढ़ापन या सुन्नपन में चिकित्सा चाहिए। पट्टी लगा देने से फ्रैक्चर की संभावना समाप्त नहीं होती।

बाद की समीक्षा

हलचल या सूजन के साथ पट्टी की कसावट बदल सकती है। आराम, परिसंचरण और सिरा स्थिर रहना देखते रहें।

> जोड़ की सुरक्षित स्थिति और समान सहारा, केवल आठाकार आकृति बनाने से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

पैर और टखने की पट्टी

Foot and Ankle Bandaging

सामान्य दिशा

पैर या टखने की चयनित चोट में ड्रेसिंग तथा उपयुक्त आठाकार सहारा उपयोग हो सकता है। अंग आरामदायक स्थिति में रहे; संदिग्ध फ्रैक्चर को सीधा या जबरदस्ती मोड़ना नहीं।

तकनीक का आधार

पैर पर आरंभिक पकड़ बनाएँ। पट्टी को पैर के ऊपर तिरछी ले जाकर टखने के आसपास और फिर पैर की ओर लौटाएँ। क्रमिक आठाकार चक्करों से आवश्यक क्षेत्र ढकें। अंत सुरक्षित रखें तथा पैर की उँगलियों के सिरे देखें।

सावधानियाँ

- पट्टी जूते के भीतर मोटा दबाव-बिंदु न बनाए।
- उँगली ठंडी, नीली या सुन्न हो तो तुरंत समीक्षा करें।
- बहुत दर्द या भार न रख सकने पर केवल “मोच” मानकर न चलाएँ।
- इलास्टिक पट्टी को अधिकतम खींचकर न लपेटें।

उपचारात्मक संपीड़न से अंतर

पैर की साधारण चोट का सहारा और शिराजनित अल्सर की चिकित्सकीय संपीड़न पट्टी अलग जरूरतें हैं। लंबे समय के संपीड़न के लिए रक्त परिसंचरण तथा घाव का पेशेवर आकलन जरूरी है।

> टखने की पट्टी सहारा दे सकती है; गंभीर चोट की जाँच और चिकित्सा का विकल्प नहीं है।

सिर, आँख और कान के पास ड्रेसिंग

Scalp, Eye and Ear-area Dressing

सिर का सामान्य घाव

छोटे सतही घाव में उपयुक्त पैड तथा सुरक्षित स्थानीय बंधन उपयोग हो सकता है। बेहोशी, भ्रम, उल्टी या बड़ी चोट में व्यक्ति की प्रतिक्रिया और श्वसन देखते हुए आपात मदद बुलाएँ।

सिर की विशेष सावधानी

संदिग्ध खोपड़ी फ्रैक्चर, गहरी वस्तु या निकले ऊतक पर सीधा दबाव न दें। कैपेलीन या अन्य ढकाव का आकार विशेषज्ञ सहायता की जरूरत समाप्त नहीं करता।

आँख की चोट

स्थिति	दिशा
रसायन	पहले तुरंत पर्याप्त पानी से सिंचाई और चिकित्सा
गहरी चोट या फँसी वस्तु	दबाव न दें, न निकालें; उपयुक्त सुरक्षा और विशेषज्ञ सेवा
चयनित सतही समस्या	चिकित्सकीय निर्देश के अनुसार स्थानीय आवरण

आँख-पैड की सीमा

हर आँख की समस्या में कसकर पट्टी बाँधना उचित नहीं है। गहरी चोट में दबाव के बिना कठोर सुरक्षा-शील्ड की जरूरत हो सकती है। दोनों आँखें नियमित रूप से ढक देना सामान्य घरेलू नियम नहीं है।

कान से स्राव

सिर की चोट के बाद कान से रक्त या तरल आए तो भीतर रुई या पैड ठूँसकर बंद न करें; तत्काल चिकित्सा लें।

> संवेदनशील क्षेत्र में दबाव से बचाव और चोट के अनुसार सही सेवा महत्वपूर्ण है।

छाती, पेट और विशेष बंधन

Chest, Abdomen and Special Bandages

सांस की स्वतंत्रता

छाती के चारों ओर पट्टी इतनी न कसें कि साँस लेना बाधित हो। पसली की चोट में पूरे सीने को कसकर बाँधना सामान्य प्राथमिक सहायता नहीं है।

खुले छाती के घाव

112 बुलाएँ। ऐसे घाव को हवा बंद करने वाली साधारण ड्रेसिंग से सील न करें। प्रशिक्षित व्यक्ति उपयुक्त विशेष वेंटेड या गैर-अवरोधक ड्रेसिंग उपलब्ध हो तो निर्धारित दिशा में उपयोग कर सकता है।

पेट की बड़ी चोट

बाहर निकले ऊतक को वापस न धकेलें और उस पर दबाव न दें। स्वच्छ, उपयुक्त गैर-चिपकने वाली सुरक्षा तथा तत्काल विशेषज्ञ सहायता की व्यवस्था करें। भोजन-पेय देकर या कसकर बाँधकर देरी न करें।

विशेष पट्टियों का परिचय

चार-पूँछ वाली (**Four-Tailed**) और अनेक-पूँछ वाली (**Many-Tailed**) पट्टियों का उपयोग चयनित क्षेत्रों में पढ़ाया जाता है। स्कल्टेटस (**Scultetus**) पट्टी अनेक सिरों वाली परंपरागत व्यवस्था का उदाहरण है।

उपयोग की सीमा

इन रूपों की पहचान और वास्तविक रोगी में उनका उपयोग अलग स्तर के कौशल हैं। घाव, श्वसन और चिकित्सकीय योजना के अनुसार कार्य करें।

> छाती-पेट की गंभीर चोट को सामान्य अंग की ड्रेसिंग की तरह न समझें।

दबाव ड्रेसिंग और गंभीर रक्तस्राव

Pressure Dressings and Severe Bleeding

दबाव का उद्देश्य

दबाव ड्रेसिंग (**Pressure Dressing**) रक्तस्राव नियंत्रित रखने में सहायक हो सकती है। प्रथम प्राथमिकता साफ पैड या कपड़े से घाव पर मजबूत सीधा दबाव और आवश्यक आपात सहायता है।

मुख्य दिशा

चरण	कार्य
पहचान	जीवनघाती या लगातार रक्तस्राव देखें
सीधा दबाव	उपयुक्त पैड रखकर लगातार दबाएँ
मदद	112 और आगे की चिकित्सा
नियंत्रण के बाद	दबाव बनाए रखने वाली सुरक्षित ड्रेसिंग
समीक्षा	रक्तस्राव, चेतना और परिसंचरण देखें

विशेष अपवाद

फँसी वस्तु या बाहर निकली हड्डी पर सीधा दबाव न दें; आसपास आवश्यक सहायता करें। छाती का खुला घाव अलग परिस्थिति है।

नियंत्रण न होना

लगातार अधिक रक्तस्राव में केवल ऊपर-ऊपर पट्टियाँ जोड़कर समस्या को छिपाएँ नहीं। मजबूत दबाव जारी रखें और आपात निर्देश लें। हाथ-पैर में जीवनघाती रक्तस्राव के लिए प्रशिक्षित टूर्निकेट का सीमित उपयोग अलग तकनीक है।

परिसंचरण का संतुलन

दबाव ड्रेसिंग आवश्यक स्थान पर दबाव रखती है; सामान्यतः पूरे अंग का रक्त प्रवाह रोकना उसका उद्देश्य नहीं है।

> टूर्निकेट, दबाव ड्रेसिंग और सामान्य सहारा-पट्टी तीन अलग उपयोग हैं।

फ्रैक्चर में स्प्लिंट और पट्टी

Splints and Bandages for Fractures

स्प्लिंट का उद्देश्य

स्प्लिंट (**Splint**) घायल अंग की गति कम करने के लिए सहारा देता है। पट्टी उसे सुरक्षित रख सकती है। उचित स्थिरता दर्द और आगे की चोट कम करने में सहायता देती है।

प्रारंभिक सहायता

अंग को जिस सुरक्षित स्थिति में है उसी में सहारा दें। हड्डी को सीधा करना, जोड़ बैठाना या निकली हड्डी अंदर धकेलना नहीं। गंभीर चोट में आपात मदद बुलाएँ।

प्रशिक्षित बंधन

- आवश्यकता के अनुसार नरम पैडिंग रखें।
- स्प्लिंट के साथ बंधन उपयुक्त स्थानों पर लगाएँ।
- गाँठ, कठोर किनारा या दबाव फ्रैक्चर के ऊपर न आए।
- जहाँ उपयुक्त हो, चोट के ऊपर और नीचे के जोड़ की गति सीमित करें।
- उँगलियों का रंग, ताप और संवेदना पहले और बाद में देखें।

स्लिंग और अतिरिक्त सहारा

बाँह की चयनित चोट में स्लिंग या अतिरिक्त चौड़ी पट्टी सहायता दे सकती है। कंधे या कोहनी की गंभीर समस्या में सामान्य स्थिति बनाने के लिए जोर न दें।

प्लास्टर से अंतर

साधारण पट्टी, अस्थायी स्प्लिंट और प्लास्टर कास्ट एक ही उपचार नहीं हैं।

> प्राथमिक स्थिरता के साथ चिकित्सा और सुरक्षित परिवहन आवश्यक हैं।

जलने की चोट की ड्रेसिंग

Dressing Burns

ठंडा करना पहले

सामान्य तापजनित जलन में पहले गर्मी का संपर्क रोकें और लगभग 20 मिनट शीतल बहते पानी से प्रभावित क्षेत्र ठंडा करें। चिपका कपड़ा न खींचें तथा बाकी शरीर को ठंड से बचाएँ।

आवरण का चयन

ठंडा होने पर साफ, न चिपकने वाला उपयुक्त आवरण ढीला रखें। उपलब्ध हो तो साफ क्लिंग फिल्म को ऊपर बिछाया जा सकता है; उसे अंग के पूरे घेरे में कसकर न लपेटें। चेहरे पर क्लिंग फिल्म न रखें।

क्या न करें?

- रूई सीधे जली सतह पर न लगाएँ।
- फफोला न फोड़ें और जली त्वचा न छीलें।
- घी, तेल, मक्खन या टूथपेस्ट न लगाएँ।
- पट्टी से सूजन वाला भाग बहुत न कसें।

चिकित्सकीय ड्रेसिंग

गहरी या बड़ी जलन तथा विशेष स्थान की चोट में चिकित्सकीय मूल्यांकन आवश्यक है। आगे की विशेष ड्रेसिंग और बदलने की योजना उपचार दल तय करता है।

रसायन और बिजली

रासायनिक या विद्युत चोट का प्रारंभिक प्रबंधन अलग है। केवल ढक देने से विषैले संपर्क या अंदर की चोट की समीक्षा पूरी नहीं होती।

> जलन की ड्रेसिंग से पहले उपयुक्त ठंडा करना और चोट की गंभीरता पहचानना महत्वपूर्ण है।

जटिल, मधुमेह और शल्य घाव

Complex, Diabetic and Surgical Wounds

अलग देखभाल की जरूरत

मधुमेह के पैर का घाव, दबाव से बनी चोट, शिराजनित अल्सर और शल्य घाव साधारण छोटे कट से अलग हैं। इनके कारण, रक्त परिसंचरण, संवेदना और उपचार की योजना का आकलन जरूरी है।

स्थिति	महत्वपूर्ण पहलू
मधुमेह का पैर	संवेदना, संक्रमण, रक्त प्रवाह और दबाव कम करना
दबाव से घाव	स्थिति बदलना और दबाव का कारण कम करना
शिराजनित अल्सर	पेशेवर समीक्षा के बाद उपयुक्त संपीड़न
शल्य घाव	ऑपरेशन दल की ड्रेसिंग और समीक्षा योजना

चिकित्सा की सीमा

घाव में मृत ऊतक काटना, गहरी पैकिंग, टाँके हटाना या बहुत कसकर उपचारात्मक पट्टी लगाना बिना उपयुक्त प्रशिक्षण नहीं करना चाहिए।

संपीड़न की सावधानी

धमनियों के रक्त प्रवाह की कमी में कुछ प्रकार का संपीड़न नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए लंबे समय की संपीड़न योजना में पेशेवर परिसंचरण आकलन महत्वपूर्ण है।

चेतावनी संकेत

फैलती सूजन या लालिमा, बढ़ता दर्द, पस, बुखार, नया सुन्नपन या बदरंग अंग पर शीघ्र चिकित्सा लें।

> जटिल घाव का उपचार केवल ड्रेसिंग बदलना नहीं; उसके कारण और व्यक्ति की पूरी स्थिति पर कार्य करना है।

भंडारण, अपशिष्ट और घरेलू व्यवस्था

Storage, Waste and Home Preparation

सामग्री का भंडारण

ड्रेसिंग और पट्टियाँ साफ, सूखी और सुरक्षित जगह रखें। कीटाणुरहित पैक की सील तथा समाप्ति तिथि देखें। भीगे, फटे या दूषित पैक को सुरक्षित कीटाणुरहित सामग्री न मानें।

उपयोग के बाद

सामग्री	प्रबंधन की दिशा
रक्त या स्राव लगी ड्रेसिंग	अलग सुरक्षित थैली; स्थानीय सेवा निर्देश के अनुसार निपटान
तेज धार वाली सामग्री	अलग सुरक्षित व्यवस्था; सामान्य ढीली थैली में नहीं
पुनः उपयोग योग्य सहारा	निर्माता और देखभाल निर्देश के अनुसार सफाई
एक बार उपयोग का पैड	धोकर फिर खुले घाव पर उपयोग नहीं

घर में तैयारी

टेप, सही आकार की पट्टियाँ, दस्ताने और ड्रेसिंग की उपलब्धता रखें। जरूरत पर आसानी से मिलें, लेकिन बच्चे और पालतू की पहुँच से सुरक्षित हों।

उपयोग की जानकारी

परिवार को पता हो कि किस सामग्री का संपर्क घाव से हो सकता है और कौन केवल बाहरी सहारा है। पढ़ने योग्य लेबल और व्यवस्थित अलग स्थान उपयोगी हैं।

नियमित समीक्षा

पेटी में बची मात्रा, पैक की अवस्था और उपयोग के बाद पूर्ति देखें।

> सही भंडारण और सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन भी ड्रेसिंग की गुणवत्ता का भाग हैं।

तकनीक, स्थान और सामान्य गलतियाँ

Matching Techniques and Avoiding Errors

जरूरत या क्षेत्र	सामान्य दिशा
शुरुआत या अंत स्थिर करना	वृत्ताकार चक्कर
लंबा लगभग बेलनाकार भाग	सर्पिल
बदलती मोटाई, गैर-लचीली पट्टी	चयनित उलटी सर्पिल
जोड़ का सहारा	आठाकार
अंगूठा या चयनित कंधा-कूल्हा क्षेत्र	स्पाइका
गोल या बंद सिरा	आवर्ती
अग्रबाहु का सहारा	उपयुक्त स्लिंग

गलतियों से बचाव

- घाव-संपर्क पैड को हाथ से छूना।
- इलास्टिक पट्टी को अधिकतम खींचना।
- गाँठ या सिलवट घायल भाग पर रखना।
- उँगलियों की जाँच बिना पट्टी समाप्त मान लेना।
- दर्द या नीली उँगली को “सहारा की कसावट” कहकर छोड़ देना।
- हर आँख, छाती या जटिल घाव पर सामान्य नियम लगाना।

सुधार की दिशा

स्थिति और उद्देश्य पहले पहचानें। सही सामग्री, सुरक्षित तकनीक और बाद की समीक्षा साथ करें। जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सहायता लें।

> तकनीक का नाम सही याद होना उपयोगी है; वास्तविक व्यक्ति में सुरक्षा की समीक्षा उतनी ही जरूरी है।

अध्याय की प्रमुख अवधारणाओं का सार

Key Concepts and Chapter Review

ड्रेसिंग और पट्टी का संबंध

ड्रेसिंग घाव की सतह और उसकी जरूरत से जुड़ी है। पट्टी ड्रेसिंग की स्थिरता, सहारा या निर्धारित दबाव से जुड़ी है। तैयार उत्पाद दोनों काम मिला सकता है।

मुख्य अध्ययन-ढाँचा

विषय	प्रमुख पहचान
पट्टी के रूप	रोलर, त्रिकोणीय और ट्यूबुलर
रोलर तकनीक	वृत्ताकार, सर्पिल, उलटी सर्पिल, आठाकार, स्पाइका और आवर्ती
त्रिकोणीय उपयोग	खुला, चौड़ा मोड़, संकरा मोड़ और स्लिंग
ड्रेसिंग	उपयुक्त संपर्क-पैड, स्राव और सुरक्षित स्थिरता
सुरक्षा	हाथ की सफाई, कम स्पर्श, आराम और परिसंचरण

उपयोग का क्रम

1	स्थिति समझें	घाव, अंग और आवश्यक चिकित्सा की पहचान।
2	सामग्री चुनें	उद्देश्य के अनुसार पैड तथा पट्टी।
3	सुरक्षित लगाएँ	सफाई, कम स्पर्श और उपयुक्त तकनीक।
4	निगरानी करें	आराम, कसावट, परिसंचरण और घाव की स्थिति।

याद रखने योग्य सावधानी

सामान्य प्राथमिक सहारे में पट्टी कसकर रक्त प्रवाह नहीं रोकना चाहिए। लगातार दर्द, ठंडापन, बदरंग उँगली या सुन्नपन में तुरंत समीक्षा करें। गंभीर रक्तस्राव, विशेष अंग की चोट और जटिल घाव में चिकित्सा आवश्यक है।

मुख्य विचार

अच्छी पट्टी वह है जो उद्देश्य पूरा करे, ड्रेसिंग तथा अंग को सुरक्षित रखे और व्यक्ति की देखभाल से जुड़ी रहे।

> सही सामग्री, सही तकनीक और सही निगरानी मिलकर सुरक्षित ड्रेसिंग तथा पट्टी का उपयोग बनाते हैं।